

CHUẨN ĐIỀU TRỊ CỦA AI? SAI LỆCH THEO CHUẨN NƯỚC NGOÀI VÀ THEO PHIÊN BẢN CŨ CỦA LLM SO VỚI HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN CỦA BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Ngô Bình Minh¹, Ngô Bình Thông², Trần Đoàn Mai Hương³

¹Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

²Khoa Y, Trường Đại học Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

³Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Tác giả liên hệ: Ngô Bình Minh, ngobinhminh.st@tdtu.edu.vn

ĐẶT VẤN ĐỀ: Người học và nhân viên y tế dùng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tra cứu, nhưng LLM có thể trả lời theo hướng dẫn nước ngoài hoặc bản đã bị thay thế, vốn có thể khác hướng dẫn Bộ Y tế về liều, ngưỡng và thuốc.

MỤC TIÊU: Đo sai lệch của LLM so với hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và phân loại mỗi lỗi theo nguồn (nước ngoài có tên, bản cũ, hay không khớp nguồn nào).

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Thí điểm trên 65 khuyến cáo có giá trị cụ thể, trích nguyên văn từ PDF chính thức; 61 khuyến cáo từ 12 văn bản còn hiệu lực được phân tích. Trích dẫn được hai lượt AI (Claude) kiểm riêng, mù, có trọng tài. Khuyến cáo được gán giá trị WHO, Mỹ, châu Âu có phiên bản, giá trị bản cũ và giá trị mới sinh theo quy tắc (khi có) để đối chứng trùng hợp ngẫu nhiên. Qwen3-8B (chạy cục bộ trên laptop) trả lời bằng tiếng Việt và tiếng Anh ở ba điều kiện: không nêu quốc gia, hỏi "theo Bộ Y tế", và kèm đoạn hướng dẫn. Câu trả lời được chấm bằng quy tắc so giá trị định trước và được kiểm lại bằng hai lượt chấm AI mù có trọng tài.

KẾT QUẢ: Với câu trả lời ngắn, bộ chấm quy tắc khớp nhân do AI phân xử ở 89,5% (kappa 0,83). Hỏi "theo Bộ Y tế" bằng tiếng Việt, trên 20 khuyến cáo khác ít nhất một hướng dẫn nước ngoài có tên, mô hình đúng 7 (35,0%; KTC 95% 15,4%–59,2%), trùng giá trị nước ngoài 2, không khớp giá trị đối chiếu nào 7, không trả lời 4. Trên 15 khuyến cáo có môi: trùng nước ngoài 2, trùng môi 0 (trả lời ngắn); trắc nghiệm 5 và 4 trên 26 câu. Trên 20 khuyến cáo có bản cũ, 3 câu trùng giá trị bản cũ. Khi kèm đoạn hướng dẫn, số câu đúng là 13/20 với khuyến cáo xung đột (9 câu tốt lên, 3 câu xấu đi; $p = 0,15$) và 19/21 với khuyến cáo trùng chuẩn quốc tế (không kèm: 9/21).

KẾT LUẬN: Ở mô hình mở nhỏ này, phần lớn lỗi là giá trị không khớp nguồn nào đã ghi nhận; chưa thấy khuynh hướng theo chuẩn nước ngoài vượt mức trùng ngẫu nhiên. Kèm văn bản Bộ Y tế làm tăng số câu đúng nhưng vẫn còn sai. Kết quả sơ bộ trên mẫu chọn tay, kiểm bằng AI, chưa có bác sĩ duyệt; nghiên cứu chính sẽ kiểm định trên toàn kho hướng dẫn và nhiều mô hình mở.

TỪ KHÓA: mô hình ngôn ngữ lớn; hướng dẫn điều trị; bộ y tế; đánh giá mô hình; giáo dục y khoa

Bài chưa được đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế. Hình thức báo cáo: Oral.